

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE PADUA — VERSIÓN COMPLETA (IP-60)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Integral de Obsesiones, Compulsiones y Pérdida de Control Mental

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Padua - Versión Clásica de 60 Ítems (IP).
Nombre Original (Inglés)	<i>Padua Inventory (PI / IP-60)</i>
Autor Original	Prof. Ezio Sanavio (1988), Università degli Studi di Padova, Italia.
Adaptaciones Españolas	Ibáñez, Olmedo, Peñate y González (2002, validación española en RIPCS); Fernández-Montalvo et al. (1998).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación de sintomatología obsesivo-compulsiva multi-dimensional.
Tipo de Instrumento	Escala de autoinforme de 60 reactivos politómicos puntuados en escala Likert de 5 puntos (0 a 4).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (>= 15 años). Ámbitos clínicos ambulatorios y hospitalarios de salud mental.
Tiempo de Administración	15 a 20 minutos.
Régimen de Licencia	Uso académico y clínico autorizado para investigación y práctica asistencial sin fines comerciales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO FENOMENOLÓGICO DE SANAVIO

El Inventario de Padua fue desarrollado por Ezio Sanavio (1988) para proporcionar a la psicopatología clínica un inventario exhaustivo de síntomas obsesivos y compulsivos, superando la brevedad telegráfica del MOCI (Hodgson y Rachman). El IP describe comportamientos concretos y pensamientos cotidianos, permitiendo captar la severidad del malestar subjetivo asociado.

El modelo factorial clásico identifica cuatro constelaciones clínicas: el sentimiento de **pérdida de control sobre los procesos cognitivos** (dudas patológicas, dificultad paralizante para tomar decisiones menores), la necesidad compulsiva de **limpieza y descontaminación**, las conductas motoras de **comprobación y reaseguro**, y la presencia de **impulsos o pensamientos temidos** que amenazan la integridad moral del sujeto. Su riqueza fenomenológica lo convierte en una guía insustituible para el diseño de jerarquías de exposición en terapia de conducta.

3. ESTRUCTURA FACTORIAL DEL INVENTARIO DE PADUA (SANAVIO, 1988; IBÁÑEZ ET AL., 2002)

Factor Clínico	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Psicopatológica
1. Pérdida Control Mental	19 ítems	0 a 76	Dudas continuas, rumiación obsesiva, dificultad decisonal y sensación de mente desordenada o vulnerable.
2. Contaminación y Lavado	11 ítems	0 a 44	Temor a gérmenes, suciedad, contagio de enfermedades graves y lavado compulsivo de manos y ropa.
3. Comprobación / Chequeo	16 ítems	0 a 64	Verificación reiterada de puertas, grifos, enchufes, cuentas numéricas y relectura compulsiva.
4. Impulsos y Precisión	14 ítems	0 a 56	Miedo a perder el control y agredir, simetría estricta, orden perfeccionista y pensamientos tabú.
PUNTUACIÓN TOTAL IP-60	1 al 60	0 a 240	Índice multidimensional exhaustivo de gravedad del trastorno obsesivo-compulsivo.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad: alfa de Cronbach global de 0.94 en muestras clínicas y de 0.92 en población general española (Ibáñez et al., 2002). Subescalas: Factores 1 a 4 presentan alfas entre 0.84 y 0.91.
Sensibilidad y Especificidad	Para el punto de corte clínico <i>ge70</i> : sensibilidad diagnóstica del 87% y especificidad del 89% frente al diagnóstico clínico de TOC (DSM-IV / DSM-5).
Validez Concurrente	Elevada correlación con la escala Y-BOCS ($r = 0.70$) y con el inventario OCI-R ($r = 0.74$).
Estabilidad Temporal	Fiabilidad test-retest $r = 0.85$ a las cuatro semanas en sujetos no clínicos estables.
Validez Discriminante	Diferencia de manera estadísticamente concluyente entre pacientes con TOC y grupos control con Trastorno de Pánico o Depresión Mayor sin síntomas obsesivos.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DE ÍTEMS

Cada uno de los 60 reactivos se responde en función de la molestia o perturbación que genera en la vida cotidiana:

- **0** = Nada | **1** = Un poco | **2** = Bastante | **3** = Mucho | **4** = Muchísimo.
- **Puntuaciones Factoriales:** Suma directa de los ítems de cada uno de los 4 factores clínicos.
- **Puntuación Total IP-60:** Suma total de los 60 reactivos. Rango: **0 a 240 puntos**.

Puntuación Total IP = 0 a 240 puntos | Punto de Corte Clínico Estándar *ge70* puntos

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (SANAVIO, 1988; IBÁÑEZ ET AL., 2002)

Estrato	Puntuación	Estado Clínico	Conducta Asistencial Recomendada
No Clínico	0 a 39	Población general / Normalidad	Pensamientos intrusivos o dudas comunes sin impacto disfuncional. Autocuidado.
Subclínico	40 a 69	Rasgos obsesivos moderados	Cierta rigidez y comprobaciones ocasionales. Psicoeducación preventiva sobre rumiaciones.
Clínico	70 a 99	Corte Positivo para TOC (≥ 70)	Sintomatología clínicamente significativa. Terapia cognitivo-conductual con técnica de EPR.
Severo	100 a 240	TOC Grave / Incapacitante	Colapso funcional masivo con rituales de horas de duración. Abordaje intensivo multimodal (EPR + ISRS).

DISTINCIÓN CON EL PI-WSUR (FORMA DE 39 ÍTEMS): El IP clásico de 60 ítems incluye una amplia exploración de dudas y rumiaciones generales (Factor 1); en contraste, la revisión PI-WSUR de Burns et al. (1996) eliminó los ítems contaminados por preocupaciones ansiosas inespecíficas, reduciéndose a 39 ítems estrictamente obsesivo-compulsivos.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y DISEÑO DE JERARQUÍAS DE EPR

CONSTRUCCIÓN DE LA JERARQUÍA TERAPÉUTICA MEDIANTE EL IP-60:

- **Paso 1:** Ordenar los reactivos que hayan recibido puntuaciones de 3 ("Mucho") o 4 ("Muchísimo") para identificar los detonantes con mayor nivel de ansiedad subjetiva (USAs).
- **Paso 2:** Si predomina el Factor 2 (Contaminación), estructurar exposición gradual a superficies sucias suprimiendo el lavado posterior.
- **Paso 3:** Si predomina el Factor 3 (Comprobación), limitar estrictamente las verificaciones a una sola vez con cronómetro y eliminar la delegación de reaseguro en familiares.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: TOC DE COMPROBACIÓN Y DUDA PATOLÓGICA

Paciente: Varón de 37 años, contable de profesión, que tarda más de dos horas cada mañana en salir de su domicilio por comprobar obsesivamente la llave del gas, las ventanas, las cerraduras y las tomas de corriente, llegando sistemáticamente tarde a su trabajo.

Resultados IP-60:

• **Puntuación Total:** 114/240 (Rango Severo — Corte Positivo).

• **Desglose factorial:** Factor 3 (Comprobaciones) = 52/64 (máximas puntuaciones en verificar cerraduras, volver hacia atrás en la carretera para comprobar no haber atropellado a nadie); Factor 1 (Pérdida de Control Mental) = 42/76 (dudas patológicas y rumiaciones); Factor 2 = 8/44; Factor 4 = 12/56.

Conducta Asistencial: Se diagnostica Trastorno Obsesivo-Compulsivo con predominio de comprobaciones (DSM-5). Se aplica Exposición con Prevención de Respuesta: salir de casa comprobando una sola vez la puerta y registrando la ansiedad hasta su descenso por habituación, asociando sertralina 150 mg/día. A las 12 semanas, la subescala de Comprobación se redujo a 14/64 y el IP total a 38/240 (rango no clínico), saliendo de casa en 10 minutos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DERIVACIÓN URGENTE

ALERTA: IMPULSOS TEMIDOS (FACTOR 4)

Los pensamientos sobre empujar a alguien o cometer agresiones reflejan egodistonia obsesiva moral y no deseo psicopático; clarificar al paciente la ausencia de peligrosidad real para aliviar la culpa.

RIESGO DERMATOLÓGICO Y SOMÁTICO

En el Factor 2, lavados extremos con lejía o desinfectantes provocan dermatitis de contacto graves, fisuras cutáneas y sobreinfecciones bacterianas que requieren tratamiento dermatológico paralelo.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Sanavio, E. (1988). Obsessions and compulsions: the Padua Inventory. *Behaviour Research and Therapy*, 26(2), 169–177.
2. Ibáñez, I., Olmedo, M., Peñate, W., & González, M. (2002). Estructura del Inventario de Padua. *Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud*, 2(2), 263–288.
3. Fernández-Montalvo, J., Echeburúa, E., & Báez, C. (1998). El Inventario de Padua: propiedades psicométricas en una muestra española. *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, 1(2), 5–18.
4. van Oppen, P. (1992). The Children's and Adult versions of the Padua Inventory: A study of its psychometric properties. *Behaviour Research and Therapy*, 30(3), 253–260.